

Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la población mayor de 18 años

Guía para profesionales de la salud. Guía No. GPC-2015-51.

Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias. Sistema General de Seguridad Social en Salud, Colombia.

Año: 2015 (publicada en marzo de 2016).

2. Resumen

Esta guía ofrece recomendaciones basadas en evidencia para la tamización, el diagnóstico, el tratamiento farmacológico y no farmacológico y la detección de complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores de 18 años en Colombia. Está dirigida al personal de salud de todos los niveles de atención. No cubre el manejo de la prediabetes, de la enfermedad renal crónica en estadios IV o V ni el manejo específico de la obesidad.

3. Índice

- 1 Portada
- 2 Resumen
- 3 Índice
- 4 Abreviaturas
- 5 Glosario
- 6 Epidemiología
- 7 Diagnóstico
- 8 Tratamiento farmacológico
- 9 Tratamiento no farmacológico y manejo
- 10 Seguimiento y pronóstico

4. Abreviaturas

- **DMT2:** diabetes mellitus tipo 2.
- **HbA1c:** hemoglobina glicosilada.
- **PTOG:** prueba de tolerancia oral a la glucosa.
- **FINDRISC:** Finnish Diabetes Risk Score, cuestionario de riesgo de diabetes.
- **TFG:** tasa de filtración glomerular.
- **iDPP-4:** inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (gliptinas).
- **iSGLT2:** inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (gliflozinas).
- **IECA / ARA2:** inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina / antagonista del receptor de angiotensina 2.

5. Glosario

- **Prediabetes (categorías con riesgo aumentado de diabetes):** incluye la glucemia de ayuno alterada (glucemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dL) y la intolerancia a la glucosa (glucemia entre 140 y 199 mg/dL a las 2 horas de una PTOG).
- **Glucemia en ayunas equívoca:** situación en la que dos mediciones de glucemia plasmática en ayunas son divergentes, una por encima de 125 mg/dL y la otra por debajo.
- **Microalbuminuria persistente:** excreción de albúmina de 30 mg o más por gramo de creatinina en la primera orina de la mañana, o de 30 mg o más en orina de 24 horas, confirmada en al menos dos de tres muestras.
- **Fragilidad:** estado de fatiga significativa con restricción severa de la movilidad y la fuerza, y mayor riesgo de caídas e institucionalización.
- **Cuidados de fin de vida:** situación de pacientes con una comorbilidad severa o una malignidad que hace prever una expectativa de vida menor de un año.

6. Epidemiología

En Colombia, entre el 7 % y el 9 % de la población adulta de 20 años o más tiene diabetes mellitus tipo 2, con una prevalencia unas cinco veces menor en las zonas rurales. Esto equivale a cerca de 2 millones de personas, de las cuales casi la mitad no conoce su diagnóstico. Un número similar tiene intolerancia a la glucosa, con muy alto riesgo de progresar. La diabetes mellitus tipo 2 está entre las cinco primeras causas de muerte del país.

Alrededor del 9 % del presupuesto de salud se destina a la diabetes, sobre todo a hospitalizaciones por complicaciones crónicas. Más del 40 % de las muertes por diabetes ocurren antes de los 60 años. Las personas con DMT2 tienen un riesgo de evento coronario de dos a cuatro veces mayor que las personas sin diabetes, equivalente al de una persona con enfermedad coronaria establecida.

Los factores de riesgo que usa la tamización son edad desde 45 años, IMC elevado, perímetro de cintura aumentado (94 cm o más en hombres, 90 cm o más en mujeres), inactividad física, bajo consumo de frutas y verduras, uso de antihipertensivos, glucosa alta previa y antecedente familiar de diabetes.

7. Diagnóstico

El diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 se establece con cualquiera de estos criterios: glucemia plasmática en ayunas de 126 mg/dL o más; glucemia plasmática de 200 mg/dL o más a las 2 horas de una carga de 75 g de glucosa anhidra (PTOG); HbA1c de 6,5 % o más en cualquier momento; o, en presencia de síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso, una glucemia plasmática al azar de 200 mg/dL o más.

Para la tamización se recomienda aplicar el cuestionario FINDRISC con punto de corte de 12 (recomendación 1, fuerte a favor, calidad de evidencia moderada). En población colombiana, este punto de corte tiene una sensibilidad del 74 % y una especificidad del 60 %. El puntaje máximo es 26 y debe aplicarlo personal capacitado. A toda persona con puntaje de 12 o más se le hace una prueba diagnóstica, preferiblemente la glucemia plasmática en ayunas. Si el puntaje es menor de 12, se educa en estilos de vida saludables y se repite la tamización a los tres años.

Cuando la glucemia en ayunas está entre 100 y 125 mg/dL, o es equívoca, se sugiere confirmar con HbA1c, donde un valor de 6,5 % o más confirma el diagnóstico (recomendación 2, débil a favor, calidad baja). Por su sensibilidad de solo 51,8 %, si la sospecha es alta y la HbA1c resulta menor de 6,5 %, se hace una PTOG. La PTOG también puede usarse en ese rango de glucemia si el paciente la prefiere (recomendación 3, débil a favor, calidad alta). Los laboratorios deben usar métodos de HbA1c certificados por el NGSP.

Como diagnóstico diferencial, la guía separa la diabetes de las categorías con riesgo aumentado (glucemia de ayuno alterada e intolerancia a la glucosa), que se remiten a

programas de prevención. Al diagnóstico se mide la HbA1c inicial para guiar el tratamiento.

8. Tratamiento farmacológico

En pacientes con esta condición recién diagnosticada no se recomienda iniciar solo con cambios en el estilo de vida (recomendación 4, fuerte en contra). Se recomienda iniciar metformina al mismo tiempo que los cambios en el estilo de vida, aunque la HbA1c esté cerca de la meta (recomendación 5, fuerte a favor). Si el paciente está clínicamente inestable (pérdida aguda de peso, deshidratación, cetosis, glucemias muy elevadas), se inicia insulina.

Cuando la HbA1c al diagnóstico es mayor de 8 %, se recomienda terapia combinada desde el inicio con metformina y otro antidiabético oral (recomendación 9). La combinación preferida es metformina con un iDPP-4 (recomendación 10); la alternativa es metformina con un iSGLT2 (recomendación 11). Si la HbA1c es mayor de 9 % y no se pueden usar esas combinaciones, se sugiere una sulfonilurea de bajo riesgo de hipoglucemia (recomendación 12). No se sugiere combinar metformina con glibenclamida ni con tiazolidinedionas (recomendaciones 13 y 14).

Si con metformina en monoterapia no se alcanza la meta (HbA1c mayor de 7 %) en tres a seis meses, se agrega un segundo antidiabético oral (recomendación 15): como primera opción un iDPP-4 (recomendación 16), como alternativa un iSGLT2 (recomendación 17) y, si ninguno está disponible, una sulfonilurea de bajo riesgo (recomendación 18). Un agonista de GLP-1 también se sugiere por su beneficio sobre el peso (recomendación 21). Si falla la terapia dual, el tercer medicamento es insulina basal en pacientes con IMC menor de 30 (recomendación 22), o un agonista de GLP-1 junto con metformina e iSGLT2 en pacientes con IMC de 30 o más (recomendaciones 23 y 24).

Tabla 1. Antidiabéticos: dosis, frecuencia, duración y observaciones

Fármaco	Dosis	Frecuencia	Duración	Observaciones
Metformina	Inicio 500 mg/día, titulación hasta 1000 mg	Hasta 2 veces al día	Continúa; reevaluar a los 3-6 meses	Máximo 1000 mg/día si TFG < 50 ml/min; suspender si TFG < 30 ml/min. Contraindicada con riesgo alto de acidosis láctica (hipoxemia severa, falla hepática, alcoholismo)
iDPP-4 (gliptinas)	No especificada en la guía	No especificada	Continúa	Primera opción como segundo fármaco. Ajustar dosis si TFG < 50 ml/min, excepto linagliptina. No aumenta el peso
iSGLT2 (gliflozinas)	No especificada en la guía	No especificada	Continúa	Alternativa al iDPP-4. Vigilar infecciones genitourinarias; menor eficacia con deterioro renal significativo
Glimepirida o glicazida	No especificada en la guía	No especificada	Continúa	Solo si no hay iDPP-4 ni iSGLT2. Requiere educación y automonitoreo por riesgo de hipoglucemia. No usar si TFG < 30 ml/min, excepto glipizida
Glibenclamida	No aplica	No aplica	No aplica	No se sugiere por alto riesgo de hipoglucemia
Tiazolidinedionas (pioglitazona)	No aplica	No aplica	No aplica	No se sugieren por riesgo de edema, falla cardíaca y fracturas
Agonista de GLP-1	Titulación progresiva según cada producto	Una o dos veces al día, o semanal	Continúa	Inyección subcutánea; beneficio sobre el peso; efectos gastrointestinales (náusea, vómito)
Insulina basal NPH	10 U/día o 0,2 U/kg/día; subir 2-4 U si la glucemia en ayunas supera la meta 2-3 días	Una vez al día, al acostarse (10-11 p. m.)	Continúa	Tercer fármaco en pacientes con IMC < 30
Insulina análoga de acción prolongada (glargina, detemir, degludec)	10 U/día o 0,2 U/kg/día, misma titulación	Una vez al día a hora fija; detemir puede darse dos veces	Continúa	Menor riesgo de hipoglucemia que la NPH

9. Tratamiento no farmacológico y manejo

Con exceso de peso, se indica dieta hipocalórica hasta acercarse a un IMC de 25 kg/m². Se sugiere una dieta mediterránea adaptada al medio (recomendación 6): predominio de vegetales, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutas enteras, frutos secos y aceite de oliva; consumo moderado de pescado, aves y lácteos bajos en grasa; y consumo esporádico de carnes rojas, huevos y granos refinados. No se debe estimular el consumo habitual de alcohol.

Se sugiere ejercicio aeróbico de intensidad moderada (recomendación 7), como caminar, montar en bicicleta, nadar o bailar, por lo menos 150 minutos a la semana, sin superar una frecuencia cardíaca de $(220 - \text{edad}) \times 0,7$. El ejercicio de resistencia con pesas, gradual en carga y frecuencia, se sugiere si el paciente lo prefiere (recomendación 8). Con limitaciones de movilidad, el ejercicio lo individualiza un fisiatra o médico del deporte.

Todo paciente debe ingresar a un programa educativo continuo liderado por un educador en diabetes certificado. El manejo es multifactorial e incluye control de dislipidemia, hipertensión arterial y tabaquismo. En pacientes con IMC de 35 kg/m² o más puede considerarse cirugía bariátrica si cumplen criterios. Se deriva a un equipo especializado si no hay respuesta con insulina basal o agonistas de GLP-1.

10. Seguimiento y pronóstico

La meta general es una HbA1c de 7 % o menos, controlada cada tres a seis meses. En menores de 65 años sin comorbilidades serias puede buscarse 6,5 %. En mayores de 65 años no se recomienda intensificar el tratamiento para acercarse a valores normales (recomendación 25); si son funcionalmente independientes, la meta es la misma de 7 % (recomendación 26); si tienen fragilidad, demencia o alto riesgo de hipoglucemia, se sugiere una HbA1c entre 7 % y 8 % (recomendación 27); y en cuidados de fin de vida el objetivo se limita a evitar la hiperglucemia sintomática (recomendación 28). En pacientes con enfermedad cardiovascular previa no se recomienda buscar una HbA1c menor de 6,5 % (recomendación 29).

Desde el diagnóstico, y luego cada año, se tamizan las complicaciones: retinopatía con fotografía no midriática u oftalmoscopia; neuropatía con evaluación de sensibilidad vibratoria y táctil en pies; y nefropatía con albuminuria y TFG. Si hay microalbuminuria persistente se sugiere iniciar IECA o ARA2 aunque no haya hipertensión (recomendación 31), con meta de presión sistólica entre 130 y 139 mmHg y diastólica de 80 mmHg o menos. No se sugiere tamizar enfermedad coronaria en pacientes asintomáticos (recomendación 30). Son signos de alarma los síntomas de hipoglucemia, los síntomas coronarios (incluida la disnea súbita) y la descompensación con cetosis o deshidratación.